

QCM 1. Les contre-indications à la paracentèse sont les suivantes sauf :

- A. Patients dont l'état général est altéré
- B. Abdomen chirurgical aigu
- C. Diathèse hémorragique
- D. Grossesse ou gros kystes ovariens
- E. Collections liquides volumineuses qui provoquent des troubles hémodynamiques et respiratoires dus à la compression du diaphragme ou de la veine cave inférieure

QCM 2. Dans la définition de la constipation, le critère du nombre de selles hebdomadaires (selles par semaines) fait référence à :

- A. Une évacuation hebdomadaire ou moins
- B. Deux évacuations hebdomadaires ou moins
- C. Trois évacuation hebdomadaire ou moins
- D. Quatre évacuation hebdomadaire ou moins
- E. Moins d'une évacuation quotidienne

QCM 3. Les objectifs pour le traitement des escarres sont les suivants sauf :

- A. Contrôle de la douleur et de l'inconfort
- B. Augmentation de la mobilité articulaire et de la force musculaire
- C. Prévenir l'infection des escarres
- D. Contrôle des odeurs et des exsudats
- E. Réduction des saignements

QCM 4. L'irritation cutanée est le plus souvent causée par une fuite de matériel stomatique, les causes les plus fréquentes étant les suivantes sauf :

- A. Erythème
- B. Erosion
- C. Macération
- D. Dermatite de contact
- E. Tumeur maligne de la peau

QCM 5. Les techniques d'auto-soins et d'exercices pour le lymphœdème comprennent les suivantes :

- A. Bandage compressif
- B. Exercices isométriques
- C. Auto-massage de drainage lymphatique
- D. élévation du membre atteint
- E. Contrôle du poids corporel

QCM 6. Les examens d'imagerie pour le diagnostic positif et différentiel du lymphœdème comprennent les éléments suivants sauf,

- A. Echographie/ écho Doppler
- B. TDM
- C. IRM
- D. Lymphoscintigraphie
- E. Endoscopie veineuse

QCM 7. L'étiopathogénie du lymphœdème secondaire est représenté par les suivantes causes sauf

- A. Augmentation de l'apport en protéines
- B. Une intervention chirurgicale
- C. La radiothérapie
- D. Une néoplasie
- E. Une infection

QCM 8. La phase proliférative de la cicatrisation (escarre) est représentée par :

- A. Migration des leucocytes
- B. Enlèvement des tissus morts
- C. Infiltration de la plaie avec de nouveaux vaisseaux sanguins soutenus par du tissu conjonctif
- D. Réorganisation du tissu conjonctif
- E. La formation des phlyctènes

QCM 9. Selon le degré d'évolution des ulcères de décubitus, un patient présentant un érythème, une microcirculation altérée, des écorchures superficielles et des phlyctènes

- A. Stade 1
- B. Stade 2
- C. Stade 3
- D. Stade 4
- E. Stade 5

QCM 10. Les facteurs extrinsèques prédisposant aux ulcères de décubitus sont les suivants sauf

- A. Incontinence, transpiration
- B. Alitement prolongé
- C. Mauvaise hygiène (peau, literie)
- D. Antibiotiques
- E. L'humidité (pellicule plastique ou chiffon)

QCM 11. Il existe une susceptibilité au lymphœdème chez les patients atteints des néoplasmes sauf

- A. Les tumeurs de la tête et du cou
- B. Le tube digestif
- C. Sein
- D. Gynécologique
- E. Mélanome

QCM 12. Le traitement du lymphœdème clinique précoce repose sur

- A. Compression (manchon de compression)
- B. Traitement décongestionnant complet
- C. Thérapie pneumatique
- D. Chirurgie de drainage lymphatique
- E. Mise sous vide

QCM 13. En cas de lymphœdème, selon l'indice de gravité volumique, une augmentation de 15% est incluse comme

- A. Le lymphœdème est absent
- B. Lymphœdème minime

- C. Lymphœdème léger
- D. Lymphœdème modéré
- E. Lymphœdème sévère

QCM 14. Mesures de soins et de traitement pour les œdèmes légers

- A. Diurétiques (furosémide)
- B. Lifting (soulever le membre affecté)
- C. Pompe à compression pneumatique intermittente
- D. Réchauffement du membre affecté
- E. Endoprothèse veineuse

QCM 15. Parmi les mécanismes physiopathologiques de l'œdème figurent les suivants sauf

- A. Augmentation de la pression oncotique interstitielle
- B. Augmentation de la pression hydrostatique capillaire
- C. Diminution de la pression hydrostatique interstitielle
- D. Perméabilité capillaire accrue
- E. Faible apport en sodium

QCM 16. Les éléments suivants sont valables pour l'œdème périphérique

- A. Elle peut être causée par des compression ou une thrombose des artères
- B. Est défini comme une accumulation intravasculaire de liquide
- C. Représente une accumulation de liquide dans les tissus infusés par la circulation périphériques
- D. L'un des mécanismes physiopathologiques est une augmentation de la pression artérielle
- E. L'un des mécanismes physiopathologiques est la diminution de la pression oncotique interstitielle

QCM 17. Les éléments suivants peuvent être recommandés pour le traitement de la constipation

- A. Augmenter l'apport en fibres alimentaires
- B. Imodium
- C. Argiles protectrices
- D. Lactulose
- E. Traitement chirurgical- réservé à la constipation secondaire par obstruction

QCM 18. Médicaments pouvant causer de la constipation

- A. Préparations de calcium
- B. Bloqueurs de canaux calciques
- C. Préparations de fer
- D. Analgésiques opioïdes
- E. Bisacodyl

QCM 19. Maladies dans lesquelles se manifeste la constipation secondaire :

- A. Hyperthyroïdie
- B. Hypothyroïdie
- C. Hypercalcémie
- D. Hypocalcémie
- E. Tumeurs du côlon ou du rectum

QCM 20. Constipation habituelle

- A. Elle est moins fréquente que la constipation symptomatique (secondaire)
- B. C'est la forme la plus courante de constipation
- C. Il survient plus fréquemment chez les hommes
- D. Il survient plus fréquemment chez les femmes
- E. Elle est favorisée par les erreurs alimentaires

QCM 21. Pour définir la constipation, les éléments à considérer sont

- A. La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 jours
- B. La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 semaines
- C. La durée de la symptomatologie est supérieure à 3 mois
- D. Augmentation de la consistance des selles à plus de 25% des émissions
- E. Effort de défécation ou sensation d'évacuation incomplète à plus de 25% des émissions

QCM 22. Pour le traitement de la diarrhée on peut envisager

- A. Le bisacodil
- B. Sulfate de magnésium intraveineux
- C. Imodium
- D. Augmenter l'apport en fibres
- E. Argiles protectrices

QCM 23. Diarrhée chronique

- A. Il a une durée de manifestation de plus de 5-7 jours
- B. Il dure plus de 4 semaines
- C. L'évaluation du contexte épidémiologique indiquera l'agent causal dans la plupart des cas
- D. Elle doit être différenciée de l'incontinence fécale (élimination involontaire des matières fécales lorsque la consistance des selles est plus liquide)
- E. Il doit être traité avec des antibiotiques en association pendant 10 à 14 jours

QCM 24. Diarrhée aiguë (plus de 3 selles non formées en 24h)

- A. Il peut durer jusqu'à 3 jours
- B. Cela peut durer au maximum 2-3 semaines
- C. En cas de diarrhée infectieuse, la présence de sang et de leucocytes dans les selles est un signe de gravité
- D. En cas de diarrhée infectieuse, le contexte épidémiologique sera analysé
- E. En cas d'absence de signes de gravité, la réhydratation et l'antibiothérapie sont utilisées en association pendant 7 jours

QCM 25. La diarrhée sécrétoire survient

- A. Médicaments induits par les laxatifs (bisacodil)
- B. Induit par des composés organophosphorés
- C. Induit par des entérotoxines bactériennes (vibrio cholerae)
- D. Ingestion de sulfate de magnésium pour le suicide
- E. En cas de tumeurs productrices d'hormones

QCM 26. La diarrhée osmotique survient

- A. En raison d'un écoulement d'eau de la paroi intestinale dans la lumière, afin d'isotoniser le contenu intestinal
- B. Induit par des entérotoxines bactériennes (vibrio cholerae)
- C. Ingestion de champignons vénéneux
- D. En raison de l'ingestion de polyéthylène glycol, de sorbitol, mannitol, lactulose, sulfate de magnésium
- E. Cas de malabsorption du glucose- galactose ou fructose

QCM27. La définition du syndrome diarrhéique prend en compte

- A. Nombre de selles (nombre d'évacuations) par jour
- B. La consistance des selles
- C. Augmentation de la quantité de matière émise en 24 heures (augmentation du poids des selles)
- D. Effort de défécation à plus de 25% des émissions
- E. Sensation d'échappement incomplet à plus de 25% des émissions

QCM 28. Mesures utiles pour la prévention des escarres

- A. Hygiène générale, évaluation et traitement de l'incontinence, observation régulière des points de pression
- B. Réduction du cisaillement, de la pression (mobilisation passive toutes les 2 heures, utilisation de matelas spéciaux)
- C. Mobilisation des patients
- D. Contrôle de la douleur
- E. Antibiothérapie prophylactique

QCM 29. L'utilisation d'antiseptiques dans la plaie (escarre) doit tenir compte de leurs effets secondaires potentiels :

- A. Les solutions à base de chlore peuvent être toxiques pour les tissus granuleux, maintenir l'inflammation des plaies, irriter la peau saine
- B. Peroxyde d'hydrogène : détruit le tissu de granulation, macère une peau saine
- C. Le peroxyde d'hydrogène provoque des réactions allergiques
- D. Les solutions chlorées sont associées à un risque d'embolie
- E. La povidone iodée peut retarder la cicatrisation

QCM 30. Utilisation du lavage (irrigation) pour nettoyer les plaies (escarres)

- A. Elimine les micro-organismes de la plaie
- B. Enlève les corps étrangers de la plaie
- C. Il sera fait avec des fluides froids pour prévenir la douleur
- D. Cela se fera avec fluides à température corporelle
- E. Cela se fera avec des fluides chauffés à 45-47°C pour un effet antibactérien

QCM 31. Utilisation de tampons pour nettoyer les plaies (escarres)

- A. Elimine efficacement les bactéries de la plaie
- B. Au contraire, il redistribue les bactéries à la surface de la plaie
- C. Stimule la formation de tissu de granulation
- D. Peut causer un nouveau traumatisme, détruisant le tissu granuleux
- E. Il peut laisser de fines fibres dans la plaie qui maintiennent l'inflammation

QCM 32. Le principe de cicatrisation plus rapide des escarres en milieu humide attribue les actions suivantes à l'exsudat de la plaie

- A. Laver la plaie et la garder humide
- B. C'est un bon milieu de culture pour les bactéries, favorisant leur multiplication
- C. En raison de sa teneur en leucocytes, il combat les bactéries
- D. Fournit des conditions optimales pour la migration des cellules épithéliales et la mitose
- E. Il a une action thrombotique sur la microcirculation et limite les hémorragies

QCM 33. Facteurs qui retardent la cicatrisation des escarres

- A. Apport d'albumine
- B. Transfusion
- C. Corps étrangers dans la plaie
- D. Présence d'infection et de sécrétions purulentes
- E. Stéroïdes volumineux ou à action prolongée

QCM 34. Une escarre de grade 4 peut présenter

- A. Lésions limitées au tissu sous-cutané
- B. Affectant le fascia profond
- C. Dommages musculaires
- D. Les lésions peuvent atteindre l'os
- E. Fistules

QCM 35. Les facteurs intrinsèques de prédisposition aux ulcères de décubitus sont

- A. Déficit neurologique
- B. Epilepsie
- C. Cancer, diabète, septicémie
- D. Obésité, cachexie
- E. Sédation

QCM 36. Les escarres de décubitus

- A. Elles résultent de troubles de la circulation sanguine et lymphatique au niveau de la peau et des tissus sous-jacents
- B. Ils sont le résultat d'une exposition prolongée des extrémités à des températures inférieures à 20°C
- C. Le mécanisme de la circulation altérée est la compression et le cisaillement
- D. Le mécanisme de la circulation altérée est la vasoconstriction
- E. Le mécanisme de la circulation altérée est l'hypothermie locale

QCM 37. Lors du remplacement de la collerette du dispositif stomatique, vous devez

- A. Examinez la peau autour de la stomie à la recherche de rougeurs ou de dommages
- B. Examiné l'arrière de la bride (pour l'érosion ou le liquide stomatique)
- C. Le patient doit être allongé en décubitus dorsal (clinostatisme)
- D. Pour que le patient s'allonge sur le dos
- E. Pour que le patient soit couché sur le dos, orthostatique ou assis

QCM 38. Pour prévenir l'irritation de la peau dans les systèmes de l'estomac

- A. Les appareils seront changés régulièrement

- B. L'adhésif (bride) se décollera doucement
- C. L'adhésif (bride) se décollera en une manœuvre rapide
- D. Les appareils seront remplacés en cas de crevaisson ou de brûlure
- E. Il est recommandé de ne remplacer l'appareil qu'en cas de fuite

QCM 39. La bride du système gastrique

- A. Doit être appliqué sur peau sèche
- B. Doit être appliqué sur peau humide immédiatement après le lavage à l'eau et au savon
- C. Doit être appliqué sur la peau après application d'une crème antibiotique
- D. Doit être appliqué sur la peau après application d'une solution désinfectante
- E. Il doit être coupé pour s'adapter à la taille et à la forme de la stomie

QCM 40. Un bon adhésif du système stomatique doit répondre aux caractéristiques suivantes

- A. Avoir une emprise sur la peau
- B. N'absorbe pas le liquide sur la peau
- C. Ne soit pas irritant
- D. Être sans odeur et sans goût
- E. Être facile à enlever

QCM 41. Dans le cas des personnes ayant des stomates/systèmes stomatiques (colostomie, iléostomie)

- A. La pénétration de substances intestinales sous la collerette peut provoquer des fuites
- B. La plupart des irritations cutanées péristomiales sont dues à des réactions allergiques à l'adhésif
- C. La plupart des irritations cutanées sont dues à un écoulement de la stomie
- D. Initialement, le contenu de la stomie passe sous la collerette puis sur les vêtements
- E. L'éclatement des poches est la principale cause d'irritations cutanées

QCM 42. Pratiques pour réduire le risque de lymphœdème

- A. De préférence, la ponction veineuse sur le membre à risque de lymphœdème doit être évitée
- B. Les mesures de la pression artérielle sur le membre à risque de lymphœdème doivent être évitées
- C. Utilisation de l'aspirateur pendant le vol sur le membre à risque de lymphœdème
- D. Port de gants ou de bandages compressifs dans l'avion sur le membre à risque de lymphœdème
- E. Application quotidienne de crèmes stéroïdiennes et éviter les bains sur le membre à risque de lymphœdème

QCM 43. Une susceptibilité accrue au lymphœdème survient chez les patients atteints de néoplasmes

- A. Bronchopulmonaire
- B. Tube digestif
- C. Sein
- D. Gynécologique
- E. Mélanome

QCM 44. La prévention du lymphœdème chez les personnes à risque comprend les indications suivantes

- A. S'abstenir de tout exercice
- B. Exercices spécifiques prescrits individuellement
- C. Eviter l'obésité qui est un facteur de risque de lymphœdème secondaire
- D. Evitement total de l'exposition au soleil
- E. Crèmes anti-inflammatoires

QCM 45. Les examens de laboratoire pour le diagnostic positif et différentiel du lymphœdème comprennent

- A. La fonction thyroïdienne
- B. Spirométrie
- C. Examen doppler carotidien
- D. La fonction hépatique
- E. La fonction rénale

QCM 46. Stadification du lymphœdème selon la fibrose tissulaire (stade 0 à 3) les éléments suivants sont corrects

- A. Stade 0 : subclinique (latente), avec le potentiel de devenir cliniquement évident
- B. Stade 1 : signe du godet positif, dépôts fibrogras sous-cutanés, distorsion architecturale, lymphœdème irréversible en, élévation
- C. Stade 2 : signe du godet positif et réversible en élévation
- D. Stade 3 : excroissances dermiques verruqueuses, distorsion architecturale sévère
- E. Stade 3 : signe du godet négatif en raison de l'induration

QCM 47. Les mesures pour traitement de l'œdème comprennent

- A. Application diurétiques locaux
- B. Mouvement du membre affecté
- C. Elévation de la partie affectée
- D. Massage ferme, en particulier dans les thrombophlébites profondes
- E. Réduction de la consommation de sel

QCM 48. Enquêtes utiles dans l'évaluation des œdèmes

- A. Capillaroscopie
- B. Capillarographie
- C. Echographie Doppler veineuse
- D. Examen sommaire des urines
- E. IRM (résonance magnétique nucléaire)

QCM 49. Les maladies associées à une diminution de la pression oncotique plasmatique sont

- A. Régime hyposodique
- B. Malnutrition
- C. Thrombose veineuse profonde
- D. Le syndrome néphrotique
- E. Insuffisance hépatique

QCM 50. Parmi les mécanismes physiopathologiques de l'œdème figurent

- A. Diminution de la pression oncotique plasmatique
- B. Diminution de la pression oncotique interstitielle

- C. Augmentation de la pression oncotique plasmatique
- D. Augmentation de la pression oncotique interstitielle
- E. Diminution de la perméabilité capillaire

QCM - Palliatif 2022

1. *Concernant la définition et la philosophie des soins palliatifs, quelle est la proposition fausse:
 - A. Les soins palliatifs impliquent une approche holistique : ils examinent la personne dans son ensemble
 - B. Il existe des soins palliatifs à domicile avec une équipe de médecin, d'infirmiers et des équipements spécifiques à l'hôpital
 - C. L'arbre des soins palliatifs se compose de 4 éléments du soin holistique: physique, mental, social et spirituel
 - D. Les soins palliatifs sont une approche qui améliore la qualité de vie des patients et de leurs familles en prévenant et en soulageant la souffrance
 - E. L'équipe de base pour les services de soins palliatifs à domicile se compose du psychologue et d'un responsable religieuxREP: E

2. *Concernant la douleur, quelle est la proposition correcte :
 - A. La douleur du patient ne doit pas toujours être prise en compte
 - B. S'il y a plusieurs douleurs, elle doit toujours être évaluée et traitée dans son ensemble
 - C. La première étape du traitement de la douleur consiste à choisir le bon analgésique
 - D. La première étape du traitement de la douleur consiste en une évaluation approfondie de la douleur afin d'en déterminer le type et l'intensité
 - E. L'échelle de Bristol est une échelle visuelle analogique de la douleurREP: D

3. *Concernant l'échelle d'analgésie de l'OMS :
 - A. Décrit les étapes d'utilisation de la thérapie anti-émétisante
 - B. Il classe les médicaments antalgiques selon 5 stades
 - C. Le stade I : on retrouve des médicaments puissants, tels que la morphine.
 - D. Le stade III: on retrouve des médicaments puissants, tels que la morphine et le fentanyl.
 - E. Le stade III: on retrouve des médicaments puissants tels que l'oxycodone et le tramadol.REP: D

4. * Surdosage des opioïdes:
 - A. A pour effet secondaire la constipation et on administre un laxatif
 - B. Produit un coma appelé narcose, sans bradypnée
 - C. on peut y retrouver la tachypnée
 - D. le médicament soulageant les symptômes est le métoclopramide
 - E. produit le bronchospasme sévèreREP: B

5. * Quels sont les critères retrouvés dans L'évaluation symptomatique d'Edmonton (ESAS), SAUF :
 - A. Fatigue
 - B. Nausée
 - C. Dépression
 - D. Transpiration
 - E. DyspnéeREP: D

6. *Les causes de douleurs neuropathiques sont, SAUF :
 - A. Neuropathie diabétique périphérique
 - B. Brûlure du deuxième degré
 - C. Névralgie post-herpétique
 - D. Sclérose en plaques
 - E. Névralgie du trijumeauREP: B

7. * La constipation secondaire :
- A. Survient dans l'hypothyroïdie
 - B. survient chez les patients ayant une dilatation colique
 - C. le tableau clinique se caractérise avec des rectorragies
 - D. l'examen de première intention est le TDM
 - E. le traitement de première intention est la chirurgie
- REP: A
8. *L'approche holistique implique les aspects suivants, SAUF:
- A. Physique
 - B. Chimique
 - C. Psychologique
 - D. spirituel
 - E. Social
- REP: B
9. *Le médicament antidépresseur :
- A. Phénytoïne
 - B. Dexaméthasone
 - C. Fluoxétine
 - D. Lévomépromazine
 - E. Diazépam
- REP: C
10. *Les techniques d'interventions utilisées pour soulager la douleur chronique sont, SAUF:
- A. Injections intra-articulaires
 - B. Injections intra-musculaires
 - C. Injections intra-osseuse
 - D. Cryoanalgésie
 - E. Blessure par radiofréquence
- REP: C
11. * Les 5 règles de l'OMS de l'analgésie sont, SAUF:
- A. Oral "par la bouche"
 - B. Régulée "à l'heure"
 - C. Individuel "pour les particuliers"
 - D. Conformément "par échelle"
 - E. Danger "administration"
- REP: E
12. * Constipation secondaire intervient dans les troubles suivants, SAUF:
- A. Hypocalcémie
 - B. Hypokaliémie
 - C. Hémorroïdes
 - D. Diverticulites
 - E. Hypothyroïdie
- REP: A
13. * Quelle est la propositions correcte concernant le sondage naso-gastrique:
- A. Est contre indiqué en cas de traumatisme facial sévère
 - B. La dyspnée est la complication principale
 - C. Utilisé uniquement dans un but alimentaire
 - D. L'introduction de la sonde se fait sur un patient en décubitus dorsal
 - E. La sonde est lubrifié sur toute sa longueur
- REP: A
14. * La péthidine :
- A. est un anti-émétique
 - B. n'est pas utilisé dans le traitement d'une douleur chronique
 - C. est un opioïde de stade II
 - D. est utilisé dans le traitement de la douleur chronique
 - E. a une longue durée d'action
- REP: B

15. * Les bisphosphonates :
- A. Parmi eux, on retrouve hémisuccinate d'hydrocortisone et valproate de sodium
 - B. ils sont indiqués dans les douleurs musculo squelettiques
 - C. indication dans l'hypertension intracrânienne
 - D. ils sont utiles dans les douleurs neuropathiques
 - E. Utile dans les métastases osseuses
- REP: E
16. Concernant, l'échelle visuelle analogique de la douleur (EVA) :
- A. Évalue l'état de conscience du malade
 - B. Permet de classer la douleur
 - C. La douleur est dite modérée si SAV 1-3
 - D. La douleur est dite légère si SAV 1-3
 - E. La douleur est dite intense si SAV 7-10
- REP: BDE
17. En ce qui concerne les soins palliatifs:
- A. Ils s'adressent aux patients atteints de maladies curables
 - B. Ils permettent aux patients de vivre et de se sentir valorisés jusqu'à la fin de leur vie
 - C. Ils s'adressent aux patients atteints de maladies incurables
 - D. Incluent les besoins psycho-émotionnels, sociaux et spirituels et physiques
 - E. Ne nécessitent pas un travail d'équipe
- REP : BCD
18. l'examen du système nerveux requiert:
- A. une palpation profonde de l'abdomen
 - B. une auscultation des bruits intestinaux
 - C. le test de Romberg
 - D. l'évaluation des réflexes tendineux profonds
 - E. une évaluation de l'état mental
- REP : CDE
19. En ce qui concerne la douleur nociceptive :
- A. Elle résulte de dommages au niveau des nerfs périphériques
 - B. Elle peut être somatique
 - C. Elle peut être neuropathique
 - D. Elle peut être viscérale
 - E. Elle est signalée par les récepteurs nociceptifs périphériques
- REP : BDE
20. En ce qui concerne la douleur neuropathique :
- A. Elle peut être périphérique ou central
 - B. Elle peut être causée par une douleur radiculaire des membres inférieurs
 - C. Elle peut être causée par douleur du membre fantôme
 - D. Le diagnostic doit être posé uniquement sur le résultat d'un questionnaire
 - E. elle répond toujours aux analgésiques conventionnels
- REP : ABC
21. En ce qui concerne la thérapie antalgique :
- A. Le mode d'administration intraveineuse est le protocole de choix
 - B. Est individuelle pour chaque patient
 - C. Le Stade III utilise des analgésiques opioïdes puissants (AINS, paracétamol, aspirine)
 - D. Le premier stade utilise un antalgique de type acétaminophène
 - E. Le premier stade utilise un antalgique de type oxycodone
- REP : BD
22. L'administration d'un traitement aux opioïdes par voie orale est contre-indiquée en cas de :
- A. troubles de déglutition
 - B. fistules internes
 - C. souffrance du patient
 - D. nausées et vomissements
 - E. confusion
- REP: ABDE

23. Les effets secondaires transitoires possibles des opioïdes :

- A. une sécheresse buccale
- B. une dépendance physique
- C. des hallucinations
- D. Rétention urinaire aiguë
- E. des nausées et vomissements

REP : CDE

24. Le Fentanyl :

- A. a un mode d'administration per os
- B. est un patch transdermique
- C. l'effet analgésique est immédiat
- D. est appliqué sur une zone exempte de poils et de coupures
- E. doit être placé 12 heures avant la dernière dose de DHC

REP : BDE

25. En ce qui concerne les antidépresseurs :

- A. sont indiqués pour atténuer les douleurs musculo-squelettiques
- B. sont indiqués pour atténuer les douleurs neuropathiques
- C. le méthylprednisolone est un antidépresseur de choix
- D. le paroxétine est un inhibiteur de la recapture de sérotonine
- E. le fluoxétine est un antidépresseur tricyclique

REP : BD

26. type de diarrhée

- A. Diarrhée osmotique
- B. Diarrhée sécrétoire
- C. Diarrhée de transports
- D. Diarrhée entérocytaire
- E. Diarrhée obstructive

REP: ABD

27. Effets secondaires permanents des opioïdes :

- A. Constipation
- B. Prurit
- C. Myosite
- D. Toxicité respiratoire
- E. Bouche sèche

REP: AE

28. Concernant le tramadol, les propositions vraies sont:

- A. C'est un analgésique de premier stade OMS
- B. Dose maximale de 400-600 mg/jour
- C. Demi-vie de 8 heures, quelle que soit la voie d'administration
- D. Il faut le prescrire avec vigilance chez les personnes âgées avec une insuffisance rénale
- E. Il est moins constipant que la codéine

REP: BDE

29. Le passage de la deuxième étape à la troisième étape dans le traitement de la douleur :

- A. La dose doit être augmenté à 80% si la douleur est incontrôlée
- B. La dose journalière est divisée par 6 pour déterminer la dose de morphine à libération immédiate
- C. Le tramadol équivaut à 100x la dose de morphine orale par mg/jour
- D. le dosage douloureux est $\frac{1}{6}$ de la dose pendant 24 heures
- E. Le dosage équivalent pour la morphine ne doit pas être calculer

REP : BD

30. La diarrhée est caractérisée :

- A. par la diminution anormale de la consistance des selles
- B. le nombre de selles par jour est $> 8/24h$
- C. gain de poids $> 200\text{ g}/24h$
- D. perte de poids $> 200\text{ g}/24h$
- E. la diarrhée chronique est émission de plus de 3 selles liquides pendant une durée de plus de 4 semaines

REP: ACE

31. Concernant la stimulation cérébrale profonde :

- A. est invasif
- B. produit le coma artificiel
- C. produit des paresthésies
- D. implique l'implantation d'électrodes qui stimule à long terme
- E. excite les fibres de la moelle épinière

REP: CD

32. Concernant la sonde vésicale :

- A. Il s'agit d'un tube pouvant être en caoutchouc, en métal ou en plastique
- B. L'infection urétrales aiguës est une contre indication
- C. Est indiquée en cas de rétention urinaire aiguë
- D. Est indiquée en cas de rétrécissements urétraux serrés
- E. Il existe différentes sondes selon le types et la taille: Thiemann, Bakkali, Foley, Channouf et Bento

REP: ABC

33. Les accidents dans la ponction pleurale :

- A. Les quintes de toux peuvent interrompre la ponction
- B. Se complique en pneumothorax, l'air pénétrant dans l'aiguille de ponction
- C. La "tache blanche" révèle en réalité une tachypleurite par pénétration de tissus dense
- D. douleur et saignement intense par lésion du paquet vasculaire nerveux intercostal
- E. Se complique en occlusion intestinale

REP: ABCD

34. La ponction pleurale :

- A. permet le diagnostic de la pleurésie en prélevant le liquide pleurale pour l'examen biochimique
- B. permet l'évacuation des collections liquidiennes ou aériennes
- C. il est conseillé d'utiliser cette méthode pour un patient hémophile atteint d'un épanchement
- D. Le liquide retiré peut dépasser les 1000 mL
- E. Il faut veiller à ne pas dépasser plus de 1L de liquide évacué lors de la ponction pour éviter un œdème pulmonaire ex vacuo.

REP : ABE

35. Les contre indications de la paracentèse sont :

- A. grossesse ou gros kystes ovariens
- B. hydronéphrose
- C. RGO
- D. Abdomen chirurgicale aiguë
- E. gastrite atrophique

REP: ABD

36. La sonde nasogastrique :

- A. un tube est inséré dans la lumière de l'estomac
- B. il est indiqué chez le patient ayant subi un traumatisme facial sévère
- C. il peut se compliquer en pneumonie d'aspiration
- D. il est indiqué chez le patient avec un état général altéré
- E. il peut induire une sensation d'étouffement

REP : ACDE

37. Les situations dans lesquelles la voie orale ne peut être administrée pour les médicaments opioïdes :

- A. insuffisance hépatique
 - B. Troubles du transit
 - C. Confusion
 - D. Stomie de l'intestin grêle
 - E. Troubles psychiatriques
- Rep : BCD

38. La ponction d'évacuation :

- A. permet l'évacuation du liquide spontanément ou par aspiration
 - B. le patient ne doit pas être informé ni sédater
 - C. manoeuvre de pénétration à l'aide d'une aiguille ou trocar dans une cavité du corps
 - D. l'anesthésie locale est contre indiquée dans cette manoeuvre
 - E. la vidange rapide est recommandée
- REP : AC

39. Contre indications de la ponction pleurale:

- A. Etat général très altéré
 - B. Suspicion de kyste hydatique
 - C. Coagulation sanguine
 - D. Bon état général
 - E. Constipation
- REP: ABC

40. Concernant l'examen du liquide pleural:

- A. L'examen biochimique (réaction de Rivalta) détermine la nature du liquide: exsudat ou transsudat
 - B. Un aspect jaune clair indique une cause inflammatoire séreuse
 - C. Un aspect jaune clair indique une cause de pleurésie hémorragique
 - D. Un aspect rose intense ou rouge évoque une cause hémorragique
 - E. Un aspect blanchâtre, laiteux évoque un épanchement lymphatique de type chyleux
- REP: ABDE

41. Dans quelles situations les analgésiques ne peuvent être administrés par voie orale:

- A. Troubles de la déglutition
 - B. Fistules internes
 - C. Troubles du transit
 - D. Stomie sur l'intestin grêle
 - E. pneumonie d'aspiration
- REP: ABCD

42. Quelles sont les propositions correctes concernant la définition de la constipation:

- A. Est définie en l'absence d'utilisation de laxatifs
 - B. Est définie durant plus de 3 semaines
 - C. Deux évacuations ou moins par semaine
 - D. Effort de défécation à plus de 25% des émissions
 - E. Effort de défécation à plus de 50% des émissions
- REP: ACD

43. Analgésiques néo-opioïdes sont :

- A. Morphine
 - B. Paracétamol
 - C. Aspirine
 - D. AINS
 - E. Fentanyl
- REP: BCD

44. Les co-analgésiques sont :

- A. Benzodiazépines
 - B. Corticostéroïdes
 - C. Inhibiteurs de la tyrosine kinase
 - D. antiarythmiques
 - E. anti-émétiques
- REP: ABD

45. Lesquelles des propositions ci-dessous est vraies :

- A. la diarrhée entérocytaire résulte de l'action directe d'un agent viral ou bactériologique qui pénètre dans la cellule et la détruit
 - B. la constipation d'évacuation est dû au refus de répondre à l'impulsion de déféquer
 - C. le diarrhée chronique ne rentre pas dans le tableau clinique du diabète sucré
 - D. La diarrhée sécrétoire peut être d'origine exogène lors de la consommation de café et de thé
 - E. le contexte de gravité lors de la diarrhée est établi par l'analyse sanguine et la déshydratation
- REP : ABDE

46. La stimulation du cortex moteur :

- A. la stimulation est généralement supérieur au seuil d'induction de contraction musculaire
 - B. il est efficace dans les syndromes neuropathiques douloureux
 - C. il est efficace dans les syndromes musculo-squelettiques douloureux
 - D. il est utilisé pour la migraine
 - E. le stimuli est généralement inférieur au seuil d'induction des contractions musculaires
- REP : BE

47. Concernant les traitements chirurgicales de la douleur :

- A. l'intervention chirurgicale de la colonne vertébrale corrige la déformation et améliore la compression neuronale
 - B. l'acupuncture est un traitement chirurgicale
 - C. la spondylolyse est une technique chirurgicale décompressive dans les discopathies
 - D. un des traitements peut être la radiochirurgie stéréotaxique
 - E. peut éliminer la tumeur ou l'infection
- REP: ACDE

48. Quels sont les symptômes de l'évaluation symptomatique d'Edmonton (ESAS):

- A. Nausée
 - B. Dyspnée
 - C. Vomissement
 - D. Anxiété
 - E. Bon sentiment
- REP: ABDE

49. Les contre-indications de la sonde vésicale :

- A. Hydronéphrose
 - B. Infections urétrales aiguës (risque d'insémination)
 - C. Rupture traumatique de l'urètre (création de fausses voies)
 - D. Pyélonéphrite chronique
 - E. Rétrécissements urétraux serrés (cystostomie temporaire)
- REP: BCE

50. Concernant les co-analgésiques :

- A. il n'existe pas d'association avec les neuroleptiques
 - B. toutes les douleurs ne répondent pas aux opioïdes
 - C. on peut associer des opioïdes stade II et stade III
 - D. on peut associer des opioïdes de stade I et stade II
 - E. les médicaments co analgésiques ne sont pas analgésiques
- REP : BDE